Escribas digitales

Qué son, por qué importan y cómo evaluar su encaje

De la consulta a una **nota clínica revisada**.

Para un hospital con atención en español y **Dedalus HCIS**.

10 minutos · 5 bloques

1. Qué es
2. Por qué importa
3. Mercado y encaje
4. Discusión: cómo evaluar
5. Conclusión y siguientes pasos

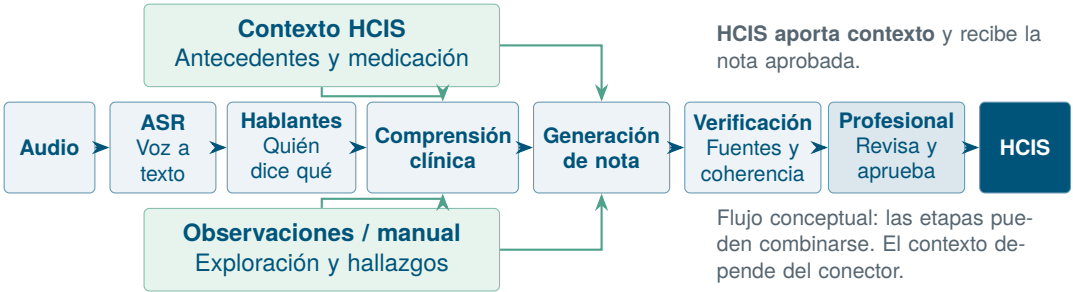
INSTITUTO RAMÓN Y CAJAL DE INVESTIGACIÓN SANITARIA IR-yCIS

Propuesta: comprobar calidad y utilidad local antes de elegir una solución.

Fuentes: Informe completo y guion del proyecto, 18/09/2026. Investigación adicional y comprobaciones selectivas: 07/10/2026. Revisión documental.

Una nota combina conversación y contexto

El escriba transforma información disponible en un borrador clínico estructurado.



HCIS aporta contexto y recibe la nota aprobada.

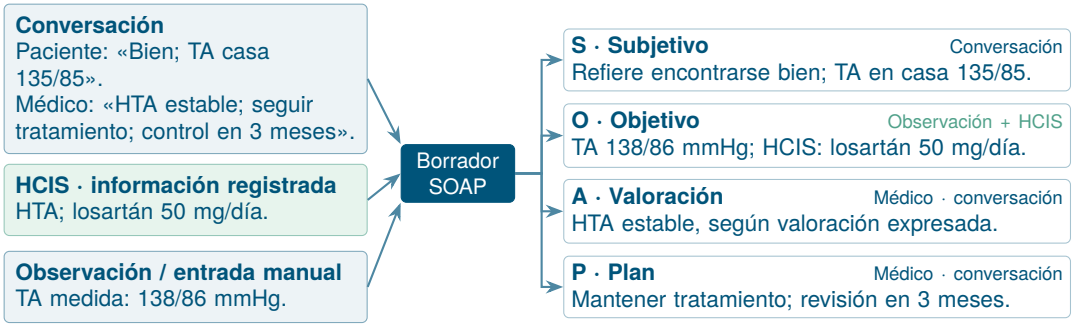
Flujo conceptual: las etapas pueden combinarse. El contexto depende del conector.

La verificación automática ayuda; el profesional confirma datos y resuelve discrepancias.

Fuentes: NHS England, v3, 2026; Nabla: transcripción y contexto; esquema conceptual del proyecto. ASR: reconocimiento automático del habla.

Ejemplo: de tres fuentes a una nota SOAP

Caso ficticio de seguimiento de hipertensión · cada dato conserva su origen.



Valoración y plan expresados por el médico; contexto de HCIS pendiente de confirmar.

Fuentes: Ejemplo propio, ilustrativo. SOAP: Subjetivo, Objetivo, Valoración (Assessment) y Plan. La ubicación de medicación puede variar según la plantilla.

Menos carga documental, más atención al paciente

El beneficio interesa si reduce el trabajo total hasta cerrar la nota.

16 min

menos de documentación por cada **8 horas de agenda**.

Asociación observada en 5 centros de EE. UU.
JAMA, 2026 · estudio observacional.

Qué queremos mejorar

- Menos escritura durante la consulta.
- Menos notas pendientes al terminar.
- Menos esfuerzo para documentar.

Qué hay que comprobar

Calidad clínica, correcciones y tiempo de revisión e incorporación a HCIS.

La oportunidad es real; el ahorro neto y la capacidad asistencial se deben medir en nuestro flujo.

Fuentes: Rotenstein et al., JAMA, 2026: 8.581 clínicos, 1.809 con acceso a escriba. Tiempo normalizado a 8 h programadas; beneficio variable. La cifra no es ahorro por consulta ni efecto causal demostrado.

Oferta en expansión y adopción rápida

La documentación es una de las grandes puertas de entrada de la IA en sanidad.

43

proveedores en nuestro inventario documental.

Muestra revisada en septiembre de 2026; no es un censo.

Conviven ofertas diferentes

- Productos individuales: Heidi, Noa, Freed.
- Ofertas hospitalarias: Tandem, Invox, Align.
- Ecosistemas HCE: Microsoft, Oracle, Abridge.
- APIs y desarrollos propios: Corti, AWS, Quirónsalud.

PHTI describe una adopción excepcionalmente rápida. La documentación y los resúmenes figuran entre los usos más extendidos en la encuesta AMA de 2026.

Fuentes: Inventario del informe: 09/09/2026 + AWS, 17/09. PHTI, 2025: experiencia de primeros adoptantes; AMA, 2026: encuesta autodeclarada en EE. UU., incluye usos distintos del escriba ambiental.

Ningún candidato tiene todo el encaje acreditado

Preselección del informe · datos y seguridad, coste, español e integración HCIS.

Candidato	Seguridad: punto de partida	HCIS y coste: pendiente decisivo
Tandem	ENS ALTA: copia parcial revisada.	HCIS no disponible. Pro: 125 €/usuario/mes con anualidad; hospital a medida.
Invox Genesis	ENS ALTA anunciado; verificar alcance Genesis.	Dictation anuncia HCIS; Genesis ofrece APIs, sin conector HCIS confirmado. Presupuesto.
Solventum Align	ENS ALTA y UE declarados; verificar expediente.	Integración HCE genérica; HCIS específico y presupuesto por confirmar.

La preselección ordena las comprobaciones. La calidad de las notas en nuestro contexto sigue por evaluar.

Fuentes: ENS: revisión del informe, 09/09/2026; no nueva auditoría. Comprobaciones selectivas 07/10: Tandem HCIS, precio; Invox API; Align. Tarifa Pro no equivale a coste hospitalario.

Dos vías para resolver las incertidumbres

Pueden compararse con el mismo banco de casos y los mismos criterios.

Evaluar proveedores filtrados

- Cerrar datos, seguridad y coste total.
- Demostrar lectura de contexto y devolución de notas a HCIS.
- Comparar calidad en español y carga de revisión.

Explorar un prototipo local

- ASR, generación y almacenamiento dentro del hospital.
- Control de datos, versiones y pruebas por lotes.
- Equipo, infraestructura, seguridad y conector por desarrollar.

La vía local puede servir de comparador y facilitar pruebas repetibles. Su calidad, capacidad y coste operativo también se deben demostrar.

Fuentes: Propuesta del proyecto; informe, apéndices E–F. OpenScribe y Phlox: referencias exploratorias, sin instalación ni validación local. Código abierto y ejecución íntegramente local son propiedades distintas.

Un banco común permite evaluar a mayor escala

Mismo audio + mismo contexto de HCIS + mismas observaciones.

Qué evaluar	Comprobación propuesta
Calidad clínica	Omisiones, adiciones, negaciones, hablantes, fármacos y dosis; gravedad.
Uso del contexto	Procedencia, fecha y paciente; datos antiguos y discrepancias.
Trabajo y operación	Revisión y cierre, fallos HCIS, latencia, uso y coste por nota completada.

Escalar: pruebas por lotes; revisión clínica de una muestra representativa y de los casos señalados.

Separar ajuste y evaluación. Las métricas automáticas apoyan la revisión; el ahorro exige observar el trabajo real.

Fuentes: Biro et al., 2025: errores y revisión; Zhou et al., EMNLP 2025: evaluación mediante listas de comprobación. Diseño local propuesto; tamaños y umbrales por acordar.

Siguiente paso: pasar de filtrar a medir calidad

Propuesta de trabajo con hitos verificables.

1. **Cerrar condiciones con la selección corta.**
   Expediente de seguridad y datos, presupuesto comparable y demostración HCIS: lectura de contexto, paciente/episodio, nota y firma.

2. **Preparar el banco y acordar criterios de éxito.**
   Casos en español, referencia clínica, versiones y errores relevantes; escenarios simulados como inicio viable.

3. **Comparar borradores antes del piloto asistencial.**
   Proveedores que superen el filtro y, si hay recursos, prototipo local; calidad, esfuerzo de corrección y coste.

4. **Pilotar el flujo completo y decidir continuidad.**
   Medir ahorro neto, uso y fallos; ampliar solo si se cumplen los criterios acordados.

Fuentes: Informe del proyecto, secciones 4–7 y apéndice F. Propuesta con contexto HCIS; protocolo por acordar.

La oportunidad merece una evaluación propia

Conclusión · qué necesitamos acordar para avanzar.

Un escriba útil combina **buenas notas, menos trabajo y encaje en HCIS**.

- **Prioridad:** en qué servicios y qué carga queremos reducir.
- **Recursos:** responsables clínico y técnico, esfuerzo y presupuesto.
- **Alcance:** candidatos comerciales y posible comparador local.

Resultado del siguiente hito: una comparación de calidad y viabilidad que permita decidir qué solución pilotar.

Fuentes: Síntesis y propuesta del proyecto. Investigación y fuentes ampliadas en contexto-investigacion.md; guion cronometrado en guion-presentacion.md.